



ERS

ENTIDADE
REGULADORA
DA SAÚDE

Acesso a cuidados de saúde mental nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde

Ficha Técnica

Título: Acesso a cuidados de saúde mental nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde

Editor: Entidade Reguladora da Saúde
Rua S. João de Brito, 621 L32, 4100-455 Porto
e-mail: geral@ers.pt | telef.: 222 092 350 | fax: 222 092 351 | website: www.ers.pt

Data: Dezembro de 2023

© Entidade Reguladora da Saúde, Porto, Portugal, 2023

A reprodução de partes do conteúdo deste documento é autorizada, exceto para fins comerciais, desde que mencionando a ERS como autora, o título do documento, o ano de publicação e a referência "Porto, Portugal".

Na execução deste documento foi atendida a privacidade dos titulares de dados pessoais. O tratamento destes dados cumpriu as normas relativas à sua proteção, nomeadamente as constantes do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).

Índice

Sumário executivo	3
1. Introdução.....	5
2. Enquadramento legal e normativo.....	10
3. Análise do acesso a cuidados de saúde mental nos hospitais do SNS	14
3.1. Vertente geográfica do acesso	14
3.2. Vertente temporal do acesso.....	21
3.3. Oferta de cuidados de saúde mental nos hospitais.....	22
3.4. Oferta de cuidados de saúde mental na comunidade pelos hospitais.....	26
3.5. Oferta de teleconsultas de psiquiatria pelos hospitais	28
4. Conclusões	29

Índice de Abreviaturas

ACES – Agrupamento de Centros de Saúde

ACSS – Administração Central do Sistema de Saúde

ARS – Administração Regional de Saúde

CSP – Cuidados da Saúde Primários

DE-SNS – Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde

DGS – Direção-Geral da Saúde

ECSM-IA – Equipa comunitária de saúde mental para a infância e adolescência

ECSM-PA – Equipas comunitárias de saúde mental para a população adulta

ERS – Entidade Reguladora da Saúde

LSM – Lei de Saúde Mental

OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico

PIB – Produto Interno Bruto

PNS – Plano Nacional de Saúde

PNSM – Programa Nacional para a Saúde Mental

PRR – Plano de Recuperação e Resiliência

RRH – Rede de Referenciação Hospitalar

SNS – Serviço Nacional de Saúde

SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde

TMRG – Tempos Máximos de Resposta Garantidos

UE – União Europeia

Sumário executivo

A crescente procura de cuidados de saúde mental, agravada após o período da pandemia de COVID-19, tem levado as autoridades nacionais e supranacionais no espaço europeu a reconhecer a necessidade de dedicar especial atenção a esta área de cuidados.

Esta tendência tem justificado um acompanhamento atento por parte da ERS da evolução do acesso aos cuidados de saúde mental em Portugal. Assim, nesse âmbito, a ERS realizou um estudo com o objetivo de analisar diversas vertentes do acesso a cuidados hospitalares de saúde mental no SNS.

Tendo como base um levantamento de informação realizado junto de todas as entidades hospitalares do SNS entre junho e agosto de 2023, esta análise do acesso teve como foco as vertentes da acessibilidade geográfica, no território de Portugal continental, à rede de oferta destes serviços, a efetiva realização de serviços no período de 2018 a 2022 e o tempo de espera pelos utentes para atendimento.

Ao nível da acessibilidade geográfica, estima-se que a Rede de Referência Hospitalar (RRH) de adultos cubra 74% da população do território de Portugal continental até 30 minutos e que a cobertura aumente para os 95% quando se considera um tempo limite de 60 minutos. Por seu turno, a RRH da infância e da adolescência cobrirá cerca de 71% da população a 30 minutos e 94% a 60 minutos.

Importa assinalar que as dotações de recursos humanos afetos a cuidados de saúde mental nos hospitais do SNS, relativas à população residente nas regiões de saúde, cresceram de 2013 para 2022 nos três tipos de profissionais de saúde considerados (aumento de 196% no rácio de médicos, de 71% no rácio de psicólogos e 90% no rácio de enfermeiros por habitantes, em Portugal continental).

Em termos de atividade desta rede de hospitais, deve destacar-se que o volume de consultas de psiquiatria tem crescido de forma sustentada desde 2018, a uma taxa média anual de 5%, e que o número de consultas de psicologia cresceu todos os anos a nível nacional, a uma taxa média de crescimento anual de 12%.

Em sentido inverso, o número de internamentos em saúde mental apresentou uma redução média de cerca de 2% ao ano entre 2018 e 2022. O número de episódios de urgência de saúde mental manteve-se constante no período analisado.

Ao nível do tempo de espera para atendimento, durante o primeiro semestre de 2023, 39% das consultas hospitalares de psiquiatria foram realizadas com um tempo de espera que excedeu os Tempos Máximos de Resposta Garantidos fixados legalmente.

Finalmente, destaca-se que o Programa Nacional Saúde Mental aponta no sentido de se dever privilegiar a prestação de cuidados na comunidade, através da criação de equipas comunitárias de saúde mental para a população adulta e para a infância e a adolescência. A este título, apurou-se a existência de um total de 66 equipas comunitárias de saúde mental dos hospitais do SNS efetivamente constituídas e em operação.

1. Introdução

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) destacou que cerca de 84 milhões de pessoas na União Europeia (UE) sofriam de problemas de saúde mental, em 2018¹. Além do sofrimento pessoal causado, estes problemas de saúde têm implicações financeiras para as sociedades, com a OCDE a estimar que os custos totais com os problemas de saúde mental ascenderiam a mais de 4% do Produto Interno Bruto (PIB) do conjunto dos 27 estados-membros da UE e Reino Unido.²

Por seu turno, o relatório “Health at a Glance” de 2022 revelou que a percentagem de jovens que reportaram sintomas de depressão em vários países da UE mais do que duplicou durante a pandemia de COVID-19, atingindo níveis de prevalência pelo menos duas vezes superiores aos dos grupos etários mais avançados.³

Com efeito, a crescente procura de cuidados de saúde mental, combinada com a quebra na prestação de cuidados durante a pandemia, veio trazer um desafio adicional à já sobrecarregada área dos cuidados de saúde mental. Na primavera de 2021 e novamente na primavera de 2022, cerca de 50% dos jovens europeus relataram que as suas necessidades não foram satisfeitas no que respeita aos cuidados de saúde mental.⁴

Mais recentemente, no relatório “Health at a Glance” de 2023, a OCDE assinalou que em resposta à pandemia, os países tomaram medidas rápidas de apoio para melhorar a saúde mental, introduzindo serviços de saúde mental de emergência e aumentando a capacidade em cuidados de saúde mental. No entanto, estes aumentos na capacidade ou no apoio nem sempre foram proporcionais às necessidades.⁵

Na publicação “Flash Eurobarometer on mental health”, de 9 de outubro de 2023⁶, é realçado que 46% dos cidadãos da UE (57% em Portugal) reportaram ter tido um problema emocional ou psicossocial nos últimos 12 meses, 89% concordam que a promoção da saúde mental é tão

¹ OECD/European Union (2018), Health at a Glance: Europe 2018: State of Health in the EU Cycle, OECD Publishing, Paris/European Union, Brussels, https://doi.org/10.1787/health_glance_eur-2018-en.

² *Idem*.

³ OECD/European Union (2022), Health at a Glance: Europe 2022: State of Health in the EU Cycle, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/507433b0-en>.

⁴ *Idem*.

⁵ OECD (2023), Health at a Glance 2023: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/7a7afb35-en>.

⁶ Disponível em https://health.ec.europa.eu/publications/mental-health-0_en.

importante como a promoção da saúde física e 25% afirmam ter sentido dificuldades no acesso a serviços de saúde mental.

Neste contexto, a Comissão Europeia, reconhecendo a importância de tornar a saúde mental uma prioridade no espaço da UE, adotou, em 7 de junho de 2023, uma Comunicação que prevê uma abordagem abrangente na área da saúde mental, no sentido de ajudar os estados-membros e todos os *stakeholders* a enfrentar os desafios nesta área de saúde pública.⁷ Esta nova abordagem deverá abranger não apenas o sector da saúde mas também outras áreas com importância para a intervenção em saúde mental, tais como a educação, a digitalização, o emprego, a investigação, o desenvolvimento urbano, o ambiente e o clima. A Comissão identifica, neste âmbito, oportunidades de financiamento de políticas e ações no valor de 1,23 biliões de euros.

Especificamente em Portugal, dados do Plano Nacional de Saúde (PNS) 2021-2030 - Saúde da população em Portugal⁸ revelam que “segundo o estudo “Saúde Mental em tempos de pandemia” [...], publicado em 2021, 34 % da população apresentava sintomas de sofrimento psicológico (45% nos profissionais de saúde), valor este superior ao encontrado, em 2013, no “Estudo Epidemiológico Nacional de Saúde Mental” (23%) [...]. Para além dos profissionais de saúde, as mulheres, os jovens adultos (entre os 18 e os 29 anos), os desempregados, as pessoas com mais baixo rendimento e os indivíduos que indicaram estar ou ter estado em quarentena, em isolamento ou já recuperados da COVID-19, bem como os indivíduos infetados que necessitaram de internamento hospitalar incluindo em cuidados intensivos, são os que apresentaram maior sofrimento psicológico”.

É neste contexto que a Entidade Reguladora da Saúde (ERS) se tem vindo a debruçar sobre várias questões relacionadas com a saúde mental em diferentes níveis da prestação de cuidados de saúde, dando continuidade ao acompanhamento dedicado a esta área que iniciou em 2015. Em concreto, naquele ano a ERS publicou o estudo “Acesso e Qualidade nos Cuidados de Saúde Mental”⁹, no qual se procedeu à apresentação da evolução legislativa na área da saúde mental e foi aferido o cumprimento dos objetivos e metas definidos no Plano Nacional de Saúde Mental 2007-2016 (PNSM). Concluiu-se, no estudo, pela existência de um desfasamento no cumprimento dos objetivos definidos, concretamente no que se referia à implementação da rede de cuidados continuados integrados de saúde mental, à definição de um modelo de financiamento da prestação

⁷ Disponível em https://health.ec.europa.eu/non-communicable-diseases/mental-health_en.

⁸ DGS/Ministério da Saúde (2022), Plano Nacional de Saúde 2021-2030 Saúde Sustentável: de tod@s para tod@s, disponível em <https://pns.dgs.pt/pns-2021-2030/>.

⁹ Disponível no website da ERS, em <https://www.ers.pt/pt/atividade/regulacao-economica/selecionar/estudos/lista-de-estudos/acesso-e-qualidade-nos-cuidados-de-saude-mental/>

de cuidados baseado em princípios de contratualização, ao desenvolvimento de uma política de avaliação e garantia de qualidade dos serviços e à criação de um sistema informático para recolha e tratamento de informação de todos os prestadores de cuidados de saúde mental. Da análise do acesso a cuidados publicamente financiados de psiquiatria concluiu-se que a oferta de serviços de saúde mental no SNS estava aquém das metas do PNSM e havia assimetrias regionais nos níveis de acesso pelas populações. Ainda no referido estudo, a ERS verificou a necessidade de se promoverem melhorias no acesso e na qualidade dos cuidados, que favorecessem a redução da prevalência da doença mental e das assimetrias regionais, designadamente mediante a definição de normas e orientações formais que instituísem requisitos mínimos de organização e funcionamento, a observar pelos prestadores de cuidados de saúde mental, e através da efetiva implementação da rede de cuidados continuados integrados de saúde mental e das disposições previstas no PNSM, e sua monitorização.

Já em 2023, a ERS publicou um outro estudo intitulado “Acesso a serviços de saúde mental nos Cuidados de Saúde Primários”¹⁰ com o objetivo de analisar o nível de acesso pelas populações a serviços de saúde mental, com foco na atividade de rastreio precoce nos Cuidados de Saúde Primários (CSP) do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e referenciação para os hospitais. As principais conclusões do estudo sublinharam a necessidade de se promoverem melhorias no acesso aos cuidados de saúde mental nos CSP, em concreto ao nível da prevenção precoce, com o intuito de reduzir a prevalência de problemas de saúde mental, designadamente pelo reforço de recursos na área da psiquiatria e psicologia nos CSP. Por outro lado, verificou-se a necessidade de adequação dos sistemas informáticos e uniformização dos procedimentos instituídos nas unidades de CSP para garantia de registo, extração e controlo pelos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) de dados sobre os cuidados de saúde mental, por ter sido identificada falta de sistematização de informação necessária ao efetivo acompanhamento deste tipo de cuidados nas unidades de CSP. Adicionalmente, resultou do estudo ser necessário uma clara definição de normas e orientações formais sobre a organização e funcionamento a observar pelas unidades de CSP, que permitam a convergência na atuação de ACES localizados nas diferentes regiões de saúde, como já identificado no estudo de 2015, afigurando-se essencial a divulgação e implementação da Rede de Referenciação Hospitalar (RRH) de Psiquiatria e Saúde Mental. Por último, o estudo afirma uma necessidade de reforço da articulação entre os CSP e os cuidados hospitalares na área de saúde mental, para reforço da prevenção e minimização, tanto quanto possível, do agravamento da doença.

¹⁰ Disponível no website da ERS, em https://www.ers.pt/media/slpzdwk/estudo_saude_mental_02-2023.pdf.

Atentas as conclusões do estudo a ERS emitiu uma recomendação à Direção Executiva do SNS (DE-SNS), por deliberação do Conselho de Administração de 13 de fevereiro de 2023, para adoção das medidas adequadas no sentido de “(i) Garantir a publicação da versão final completa do documento “Rede de Referência Hospitalar de Psiquiatria e Saúde Mental”, aprovado por despacho do Ministro da Saúde de 23 de novembro de 2015; e (ii) Proceder à divulgação do documento referido em (i) junto dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde do Serviço Nacional de Saúde, garantindo a sua implementação e promovendo a efetiva articulação entre os níveis de cuidados na área da saúde mental”, e à Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), à Direção Executiva do SNS e aos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) para adoção de medidas adequadas no sentido de garantirem a adequação dos sistemas informáticos e a uniformização dos procedimentos adotados pelas unidades de cuidados de saúde primários para registo, extração e controlo dos dados sobre cuidados de saúde mental pelos ACES.¹¹

Assim, dando continuidade ao acompanhamento na área da saúde mental, e em face do contexto de crescente atenção sobre esta área de cuidados, a ERS considerou relevante realizar agora um estudo especificamente dedicado à análise do acesso a cuidados hospitalares de saúde mental no SNS.

Neste sentido, o presente estudo tem como objetivos analisar diversas vertentes do acesso a cuidados hospitalares de saúde mental no SNS, designadamente a da distribuição geográfica dos pontos de acesso à rede de cuidados, da oferta relativa de recursos humanos e físicos para a prestação dos cuidados e do tempo de espera para atendimento.

O estudo estrutura-se nos seguintes capítulos: no capítulo 2 descreve-se o enquadramento legal e normativo da prestação de cuidados de saúde mental no SNS em Portugal; o capítulo 3 é dedicado à análise do acesso a cuidados de saúde mental nos hospitais do SNS, numa vertente geográfica, onde se faz uma descrição da rede de hospitais do SNS com oferta de saúde mental, se verifica a implementação da RRH de Psiquiatria e Saúde Mental e da RRH de Psiquiatria da Infância e da Adolescência, e se analisa a oferta relativa de recursos humanos e físicos nos hospitais da rede, e numa vertente temporal do acesso, onde se analisa o tempo de espera para acesso a consultas de psiquiatria nos hospitais do SNS; um outro ponto centra-se na avaliação da oferta de cuidados de saúde mental na comunidade pelos hospitais do SNS, verificando a disponibilidade, tipo e volume

¹¹ Disponível no *website* da ERS, em https://ers.pt/media/2ddjqyph/recomenda%C3%A7%C3%A3o-sa%C3%BAdo-mental-ap%C3%B3s-ai_vf.pdf.

de cuidados prestados na comunidade; e finalmente, analisa-se a disponibilidade de teleconsultas de psiquiatria nos hospitais do SNS. No capítulo final são apresentadas as principais conclusões.

2. Enquadramento legal e normativo

Como foi referido no capítulo anterior, a ERS publicou em 2015 e em fevereiro de 2023 estudos sobre os cuidados de saúde mental em Portugal, nos quais se pode encontrar uma extensa e detalhada descrição da evolução legislativa e normativa que enquadrou esta área de cuidados até 2022. Neste sentido, importa aqui mencionar dois novos diplomas, que se consubstanciam em alterações relevantes em relação ao contexto anterior.

Com efeito, em 2023 foi aprovada uma nova Lei de Saúde Mental (Lei n.º 35/2023, de 21 de julho), juntamente com a alteração de legislação conexa, do Código Penal, do Código da Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade e do Código Civil, e a revogação da anterior Lei de Saúde Mental (Lei n.º 36/98, de 24 de julho).

Assim, a atual Lei da Saúde Mental (LSM) estabelece “[...] os fundamentos e os objetivos da política de saúde mental, consagra os direitos e deveres das pessoas com necessidade de cuidados de saúde mental e regula as restrições destes seus direitos e as garantias de proteção da sua liberdade e autonomia”. O referido diploma, entre outros conceitos, veio definir a “doença mental” como uma “[...] condição caracterizada por perturbação significativa das esferas cognitiva, emocional ou comportamental, incluída num conjunto de entidades clínicas categorizadas segundo os critérios de diagnóstico da Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde” (cfr. alínea a) do artigo 2.º da Lei n.º 35/2023, de 21 de julho).

Nesta LSM assumem destaque as novas disposições quanto a medidas de segurança de internamento de pessoas inimizáveis e quanto à sujeição a tratamento involuntário.

Em matéria especificamente relacionada com o papel do sector hospitalar na saúde mental, importa realçar que se estabelece no artigo 4.º da atual LSM, como fundamento da política de saúde mental, “a prestação de cuidados de saúde mental no ambiente menos restritivo possível, devendo o internamento hospitalar ter lugar como medida de último recurso”, e que se define como objetivo da política de saúde mental, no artigo 5.º, “concluir a transição para a prestação de cuidados de saúde mental na comunidade, tendo em vista melhorar a qualidade desses cuidados e garantir a proteção dos direitos nos serviços e entidades com intervenção na área da saúde mental”. Note-se, ainda, que no artigo 6.º se prevê que “os princípios gerais e as regras da organização e funcionamento dos serviços de saúde mental [serão] definidos em diploma próprio”.¹²

¹² Até à data de elaboração do estudo ainda não tinha sido publicado nenhum diploma adicional quanto a esta matéria.

A par da entrada em vigor desta nova LSM, a preocupação crescente com a adequação da saúde mental às necessidades da população portuguesa assume relevo com a Lei n.º 38/2023, de 2 de agosto, que veio aprovar a Lei das Grandes Opções para 2023-2026 em matéria de planeamento e da programação orçamental plurianual, que integra as medidas de política e os investimentos que as permitem concretizar.

A implementação das Grandes Opções 2023-2026 inclui um conjunto de medidas de política cujas fontes de financiamento abrangem fundos nacionais e europeus. Assim, e no que à saúde mental diz respeito, o Governo projeta “concluir a cobertura nacional de Serviços Locais de Saúde Mental, nas respostas de internamento, ambulatório e intervenção comunitária, nomeadamente com a criação de serviços de internamento nos hospitais gerais onde eles ainda não existam, assim como com a constituição de Centros de Responsabilidade Integrados, bem como “implementar os Planos Regionais de Saúde para as Demências, promovendo uma sólida resposta intersectorial às pessoas que vivem com demência, às sua famílias e cuidadores.”¹³

No âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), a saúde mental consta como um dos investimentos a executar até 2026. Concretamente, pretende-se concluir a “Reforma da Saúde Mental e implementação da Estratégia para as Demências (88 M€), contribuindo para o reforço do SNS e para a melhoria da resposta às necessidades em saúde da população portuguesa. Neste plano, regist[a]-se a entrada em vigor do Decreto-Lei de Saúde Mental, que estabelece os princípios para a organização dos cuidados de saúde mental.”¹⁴

Adicionalmente, com o intuito de combater o abandono no ensino superior, as Grandes Opções contemplam “Lançar um programa de apoio à saúde mental no ensino superior, apoiando as [Instituições de Ensino Superior] IES na consolidação de mecanismos de apoio psicológico aos estudantes e na concretização de estratégias de intervenção precoce e de abordagem preventiva a este fenómeno”.¹⁵

Redes de referenciação Hospitalar

A primeira RRH de Psiquiatria e Saúde Mental foi publicada em 2001, tendo em 2004 sido publicada pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) uma versão atualizada da mesma, diferenciando algumas áreas, designadamente, a rede de psiquiatria de adultos, a rede de psiquiatria da infância e da adolescência, a rede de urgências, psiquiatria forense e as instituições sociais. Por seu turno, a

¹³ Cfr. Ponto 4.4 do anexo I da Lei n.º 38/2023, de 2 de agosto.

¹⁴ *Idem*.

¹⁵ Cfr. Ponto 7.4 do anexo I da Lei n.º 38/2023, de 2 de agosto.

RRH de Psiquiatria da Infância e da Adolescência foi publicada de forma autónoma, através de despacho da Ministra da Saúde de 15 de junho de 2011.

Recorde-se que, tal como mencionado no estudo da ERS relativo ao acesso a serviços de saúde mental nos cuidados de saúde primários, os programas considerados prioritários de saúde, onde se inclui a saúde mental, foram alvo de atualização¹⁶, tendo sido publicadas novas versões da RRH de Psiquiatria e Saúde Mental e da RRH de Psiquiatria da Infância e da Adolescência, aprovadas por despacho do Ministro da Saúde de 23 de novembro de 2015 e por despacho do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde a 9 de outubro de 2018, respetivamente.

Porém, considerando que uma das conclusões do referido estudo da ERS identificou não se encontrar disponível a versão completa da RRH de Psiquiatria e Saúde Mental, incluindo o anexo relativo à respetiva arquitetura, o Conselho de Administração da ERS decidiu, em 13 de fevereiro de 2023¹⁷, e como referido anteriormente, emitir uma recomendação¹⁸ à DE-SNS, no que importa aqui referir, no sentido de: “(i) [g]arantir a publicação da versão final completa do documento “Rede de Referência Hospitalar de Psiquiatria e Saúde Mental”, aprovado por despacho do Ministro da Saúde de 23 de novembro de 2015; (ii) [p]roceder à divulgação do documento referido [...] junto dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde do Serviço Nacional de Saúde, garantindo a sua implementação e promovendo a efetiva articulação entre os níveis de cuidados na área da saúde mental”.

Nessa sequência, no âmbito do presente estudo, e por ofício do dia 19 de julho de 2023, foi solicitado pela ERS à DE-SNS que “[...] fosse remetida a versão final completa da “[RRH] de Psiquiatria e Saúde Mental” de 2015 (incluindo o anexo relativo à respetiva arquitetura), ou versão mais recente, caso existi[sse] [...]” assim como a descrição das eventuais medidas já adotadas na sequência da recomendação acima descrita.

Acontece que, da análise da resposta e dos anexos que à ERS foram enviados, não consta a RRH de Psiquiatria e Saúde Mental solicitada, mas sim a sua “versão em atualização, 2014”, que se assume ser a que está em vigor.

¹⁶ A Portaria n.º 123-A/2014, de 19 de junho, estabeleceu os critérios de criação e revisão das Redes Nacionais de Especialidades Hospitalares e de Referência (RNEHR), bem como as áreas que estas devem abranger, assim e em cumprimento do Despacho n.º 10871/2014, de 25 de agosto do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, foi criado um grupo de trabalho para a elaboração ou revisão das RNEHR, onde estava incluída a área de Saúde Mental e Psiquiatria.

¹⁷ Nos termos da alínea c) do artigo 15.º dos seus estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 126/2014, de 22 de agosto.

¹⁸ Disponível no *website* da ERS, em <https://ers.pt/media/2ddjyph/recomenda%C3%A7%C3%A3o-sa%C3%BAd-e-mental-ap%C3%B3s-a-vf.pdf>

Na referida resposta, que contemplou os esclarecimentos prestados pelo Coordenador Nacional das Políticas de Saúde Mental foi mencionado que “A RRH-PSM de 2015 está substancialmente desatualizada, uma vez que se refere a uma realidade de há quase uma década. Nestas circunstâncias, a [Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental] (CNPSM) considera que as instituições não só pouco beneficiam desta versão da RRH-PSM, como necessitam de dispor de uma versão atualizada à realidade de hoje.”. Foi ainda referido que, “[p]ara além da distância temporal, as mudanças ocorridas nos últimos três anos, fruto do retomar da reforma da saúde mental, com implicações diretas nos fluxos de orientação e no trajeto dos doentes, justificam plenamente a atualização da rede de 2015”, acrescentando que irá existir uma “nova RRH-PSM [que] irá atualizar uma parte significativa dos fluxos de referenciação, mas não a sua totalidade, uma vez que alguns dos elementos nucleares (ex: serviços de internamento em hospitais gerais que irão permitir o encerramento das unidades análogas ainda alocadas a hospitais psiquiátricos) só deverão estar finalizados em 2026, no quadro de financiamento pelo PRR.”.

3. Análise do acesso a cuidados de saúde mental nos hospitais do SNS

No presente capítulo apresenta-se uma análise do acesso a cuidados de saúde mental nos hospitais do SNS, com foco nas vertentes da acessibilidade geográfica, no território de Portugal continental, à rede de oferta destes serviços, da efetiva realização de serviços no período de 2018 a 2022 e do tempo de espera pelos utentes para atendimento.

Para suportar esta análise, a ERS realizou um levantamento de informação¹⁹ junto de todas as entidades hospitalares do SNS entre junho e agosto de 2023, abrangendo diversas dimensões dos serviços de saúde mental naquele no horizonte temporal.

3.1. Vertente geográfica do acesso

A tabela 1 apresenta o número de entidades hospitalares presentes em cada região de saúde que oferecem diferentes tipos de serviços na área da saúde mental. Esta informação baseia-se na verificação da efetiva atividade realizada no ano de 2022 ao nível daqueles tipos de serviços.

Tabela 1 – Número de entidades hospitalares do SNS que oferecem serviços de saúde mental

Região	Consultas de psiquiatria	Internamentos de saúde mental	Urgências de saúde mental	Consultas de psicologia	Recebe referências dos CSP para consulta de psicologia
Alentejo	4	3	2	3	3
Algarve	1	1	1	1	0
Centro	9	7	7	10	4
LVT	15	12	7	14	5
Norte	14	10	5	11	2
Total	43	33	22	39	14

Conforme se pode constatar, a nível nacional são 43 as entidades hospitalares que oferecem consultas de psiquiatria, com distribuição regional em linha com a da própria existência de hospitais da rede do SNS.²⁰ Quanto às consultas de psicologia, verifica-se que são 39 as entidades que as realizam, 14 destas recebem utentes referenciados dos cuidados de saúde primários para consulta

¹⁹ O pedido de elementos da ERS foi remetido no dia 26 de junho de 2023 a 47 entidades responsáveis por estabelecimentos hospitalares integrados no SNS.

²⁰ As regiões consideradas nas análises apresentadas neste estudo dizem respeito às áreas de jurisdição das cinco administrações regionais de saúde do SNS.

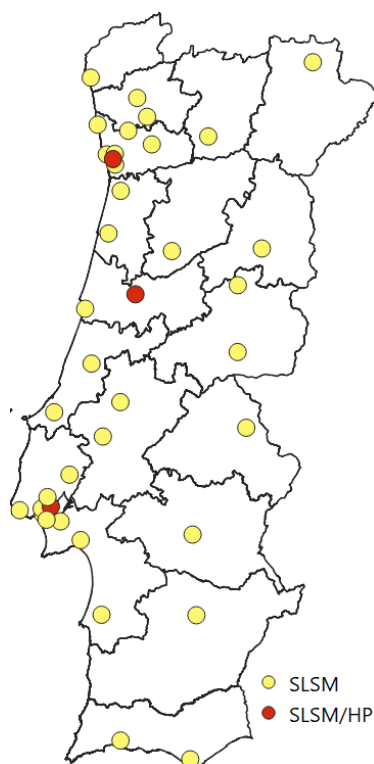
de psicologia. A oferta de serviços de internamento e de urgências na área da saúde mental acontece em, respetivamente, 33 e 22 entidades.

Importa destacar que, quando comparada esta informação com as RRH em vigor na saúde mental (em concreto, a RRH de Psiquiatria e Saúde Mental de Adultos de 2014 e a RRH de Psiquiatria da Infância e da Adolescência de 2018), se conclui que todos os hospitais abrangidos pelas redes oferecem consultas de psiquiatria.

Assim, a análise de acessibilidade geográfica à RRH equivale a concluir sobre o acesso, nessa vertente da acessibilidade geográfica, a serviços de consulta de psiquiatria. Com efeito, na figura 1 apresenta-se a localização geográfica dos pontos de rede das duas RRH e na figura 2 as localizações dos hospitais que recebem referências dos CSP para consulta de psicologia.

Figura 1 – Unidades das redes de referência hospitalar de saúde mental

RRH de adultos (2014)



RRH da Infância e da Adolescência (2018)

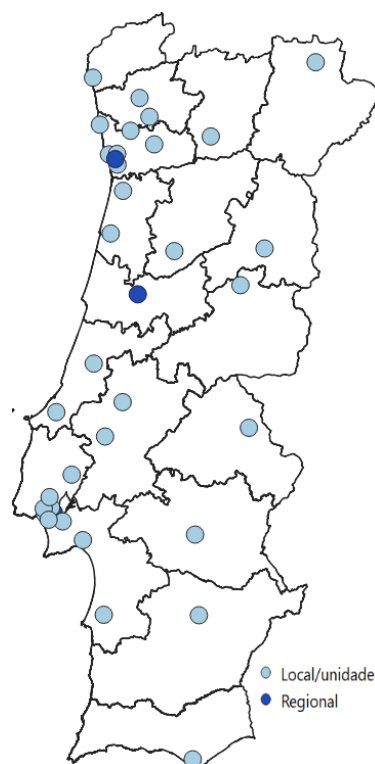
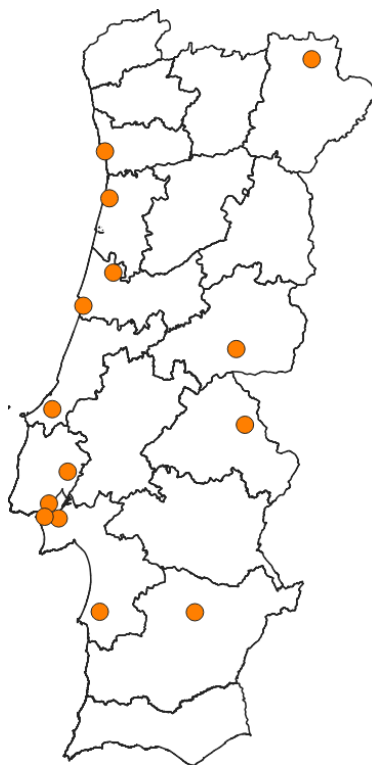


Figura 2 – Hospitais que recebem referências dos CSP para consulta de psicologia

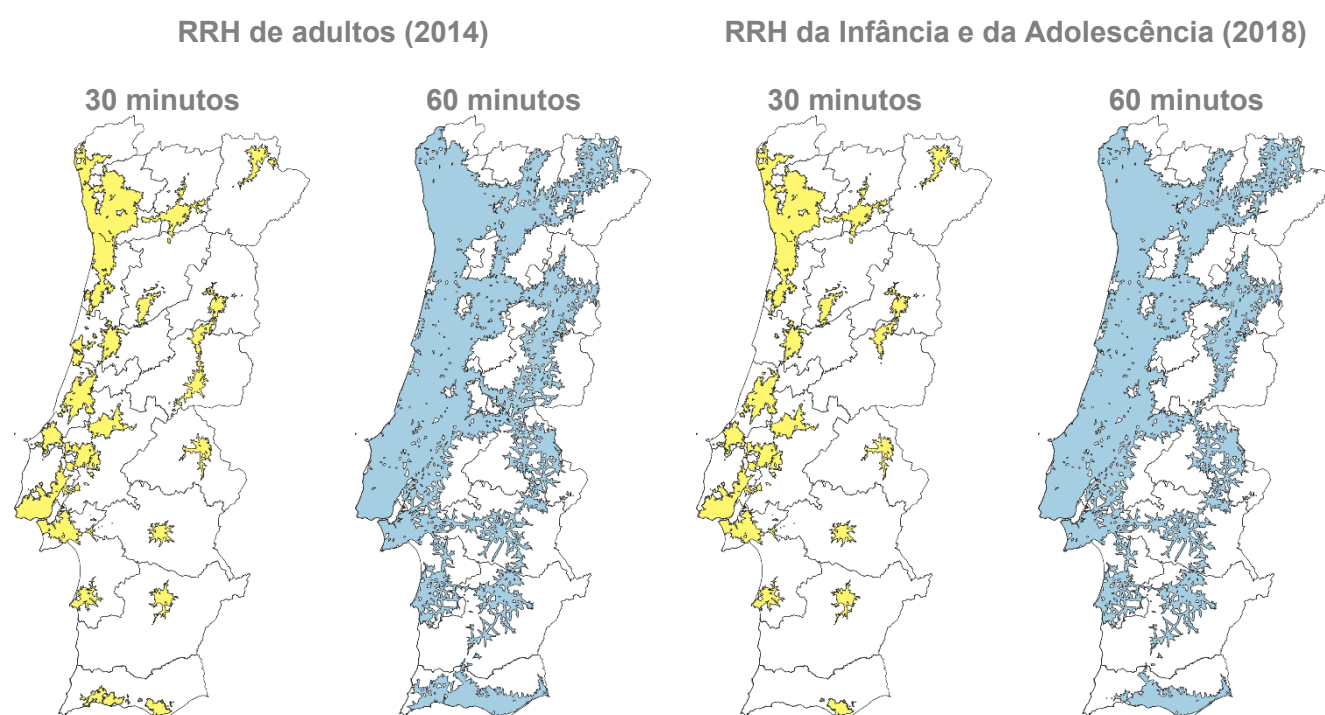


Realizou-se ainda um estudo da cobertura populacional das RRH, medida pela estimativa da população residente nas áreas geográficas de tempos de viagem até 30 e 60 minutos aos pontos das redes (áreas designadas por isócronas).²¹

Assim, conforme se apurou, estima-se que a RRH de adultos cubra 74% da população do território de Portugal continental até 30 minutos e que a cobertura aumente para os 95% quando se considera um tempo limite de 60 minutos. Por seu turno, a RRH da infância e da adolescência cobrirá cerca de 71% da população a 30 minutos e 94% a 60 minutos (figura 3 onde se ilustram as isócronas de 30 e 60 minutos de tempo de viagem).

²¹ A análise da abrangência geográfica das RRH foi realizada com o programa QGIS Desktop 3.22.15, que se trata de um *software* de informação geográfica *open source* licenciado ao abrigo da *GNU General Public License* (<https://www.qgis.org/en/site/about/index.html>). Mais especificamente, o cálculo de isócronas de abrangência geográfica foi realizado com o *plugin* ORS Tools do QGIS, ligado à API Openroute Service (<https://openrouteservice.org>), que utiliza estradas do serviço Open Street Map (<https://www.openstreetmap.org>) e dados da população do projeto Global Human Settlement publicados pela Comissão Europeia (<https://ghsl.jrc.ec.europa.eu/>). Concretamente, os dados da população utilizados são do módulo GHS Population Grid, em ficheiro *raster* publicado em 2022, que apresenta a distribuição e a densidade da população estimada para o ano de 2020, expressa em número de pessoas por célula de 100x100m (disponível em <https://data.jrc.ec.europa.eu/dataset/d6d86a90-4351-4508-99c1-cb074b022c4a>). Os *shapefiles* da rede de hospitais do SNS foram obtidos no Portal da Transparência do Ministério da Saúde em agosto de 2023 (<https://www.sns.gov.pt/transparencia/>) e os *shapefiles* do território de Portugal continental provêm da Carta Administrativa Oficial de Portugal, versão de 2022 (CAOP 2022), publicada pela Direcção-Geral do Território em <https://www.dgterritorio.gov.pt/cartografia/cartografia-tematica/caop>.

Figura 3 – Abrangência geográfica das redes de referência hospitalar de saúde mental



Na tabela 2 elencam-se os concelhos não abrangidos pelas áreas de 60 minutos de tempo de viagem às redes consideradas.

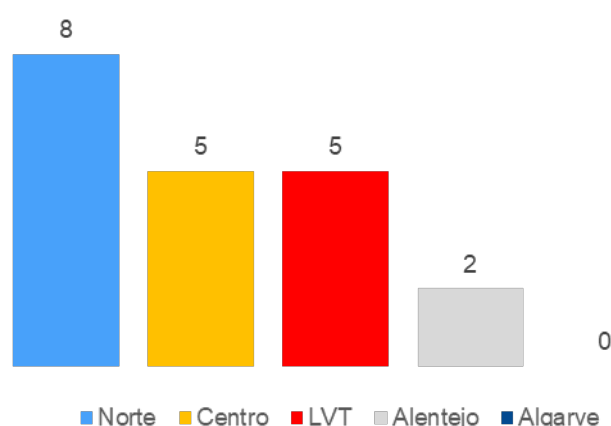
Tabela 2 – Concelhos não abrangidos pelas isócronas de 60 minutos às RRH

RRH de adultos (2014)	
NUTSIII	Concelhos
Alentejo Central	Alandroal
	Mora
	Mourão
Algarve	Alcoutim
Alto Alentejo	Campo Maior
Alto Minho	Melgaço
Alto Tâmega	Montalegre
Baixo Alentejo	Barrancos
	Moura
Beiras e Serra da Estrela	Figueira de Castelo Rodrigo
	Freixo de Espada à Cinta
	Penedono
Douro	Sernancelhe
	Góis
Região de Coimbra	Pampilhosa da Serra
Terras de Trás-os-Montes	Mogadouro

RRH da Infância e da Adolescência (2018)	
NUTSIII	Concelhos
Alentejo Central	Alandroal
	Mora
	Mourão
Algarve	Alcoutim
	Aljezur
	Monchique
	Vila do Bispo
Alto Alentejo	Campo Maior
Alto Minho	Melgaço
Alto Tâmega	Montalegre
Baixo Alentejo	Barrancos
	Moura
Beira Baixa	Oleiros
Beiras e Serra da Estrela	Figueira de Castelo Rodrigo
	Freixo de Espada à Cinta
	Penedono
Douro	Sernancelhe
	Góis
Região de Coimbra	Pampilhosa da Serra
Terras de Trás-os-Montes	Mogadouro

Em complemento aos serviços oferecidos nas unidades hospitalares do SNS, a ERS apurou que 20 destas entidades do SNS detêm protocolos com operadores não públicos para consultas, internamentos ou tratamentos na área da saúde mental, sendo esta realidade mais predominante na região Norte (figura 3).

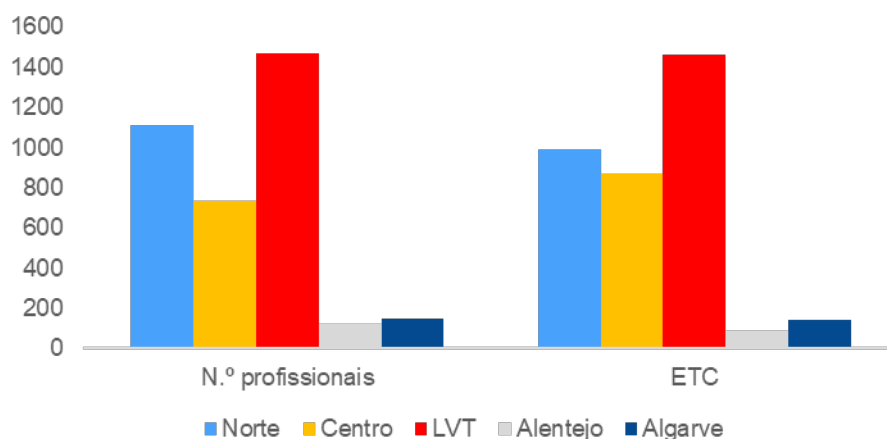
Figura 3 – Número de hospitais com protocolos com operadores não públicos para consultas, internamentos ou tratamentos na área da saúde mental



No que concerne à capacidade de oferta de serviços nestas redes, foi recolhida e analisada informação sobre o número de médicos, de enfermeiros, de psicólogos e de outros profissionais de saúde envolvidos na prestação de serviços de saúde mental nas unidades hospitalares do SNS.

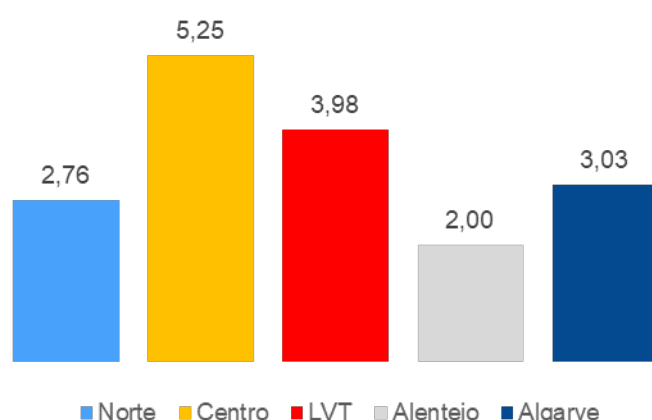
Conforme ilustra a figura 4, a região de saúde de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) destaca-se com o maior número de profissionais de saúde e as regiões de saúde do Algarve e Alentejo com uma quantidade de profissionais na saúde mental substancialmente menor que as restantes regiões. As distribuições de número de profissionais e número de equivalentes a tempo completo (ETC) são similares, embora devendo realçar-se que apenas na região do Centro o rácio de ETC por número de profissionais é superior a um.

Figura 4 – Número de profissionais de saúde na área da saúde mental nos hospitais do SNS (em 31 de dezembro de 2022)



Uma ótica mais relevante de analisar a dotação de profissionais de saúde a prestar cuidados de saúde mental em cada região passa por relativizar aquela contagem de profissionais face à população residente nas regiões. Assim, a região Centro emerge como a que apresenta a mais elevada dotação relativa de recursos humanos em saúde mental, com 5,25 profissionais de saúde (ETC) por 10.000 habitantes, sendo certo que o elevado número de profissionais disponíveis nos hospitais de Lisboa e Vale do Tejo confere à região a segunda posição em termos do indicador de base populacional.

Figura 5 – Rácio de profissionais de saúde em saúde mental nos hospitais do SNS (ETC) por 10.000 habitantes da região



As dotações relativas de recursos humanos afetos a cuidados de saúde mental nos hospitais do SNS foram comparadas às descritas no já referido estudo realizado pela ERS em 2015, valores

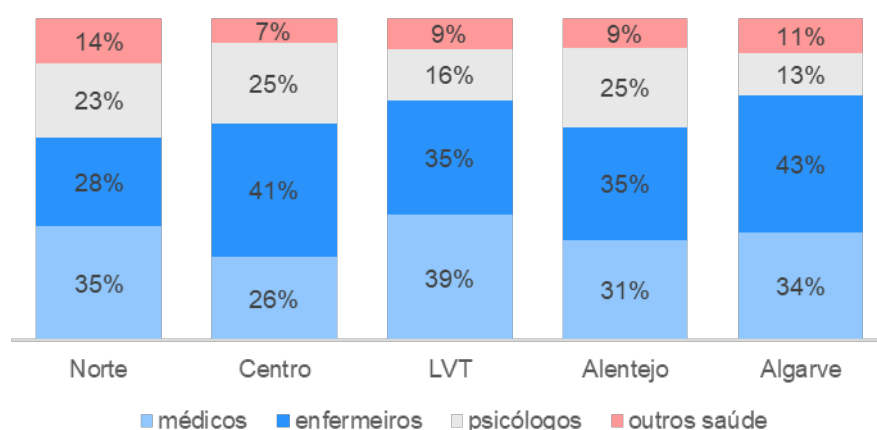
esses que diziam respeito ao ano de 2013. Da comparação pode concluir-se que nos três tipos de profissionais de saúde considerados (médicos, psicólogos e enfermeiros), as dotações relativas aumentaram desde aquela data, tendo o crescimento mais acentuado sido verificado no rácio de psiquiatras por 75.000 habitantes da região.

Tabela 3 – Rácios de profissionais de saúde em saúde mental nos hospitais do SNS (ETC) em 2013 e 2022

Região	Psiquiatras por 75.000 hab.		Psicólogos por 50.000 hab.		Enfermeiros por 50.000 hab.	
	2013	2022	2013	2022	2013	2022
Norte	2,3	6,0	1,4	1,4	2,7	5,1
Centro	3,3	7,4	0,9	4,7	6,1	14,5
LVT	2,8	9,9	1,7	2,5	4,3	7,4
Alentejo	1,8	3,7	1,0	1,9	2,8	4,6
Algarve	1,5	7,6	1,0	2,0	4,2	6,5
Total	2,6	7,7	1,4	2,4	4,0	7,6

O *skill-mix* das equipas de profissionais de saúde envolvidos em saúde mental apresenta diferenças médias entre regiões que importa destacar: os médicos são mais predominantes nos hospitais das regiões Norte e Lisboa e Vale do Tejo, mas nas demais regiões os enfermeiros são o tipo de profissional mais frequente.

Figura 6 – Peso do tipo de profissional de saúde no total de profissionais de saúde na área da saúde mental nos hospitais do SNS (em ETC a 31 de dezembro de 2022)



3.2. Vertente temporal do acesso

Para analisar a vertente temporal do acesso, recorreu-se a dados da monitorização dos tempos de espera para atendimento no SNS que vem sendo realizada pela ERS desde 2017. Concretamente, foram analisados os dados mais recentemente recolhidos, relativos à atividade de consultas realizadas durante o primeiro semestre de 2023 e aos utentes em espera no final desse período.

Conforme se sintetiza na tabela abaixo, foram realizadas pelos hospitais do SNS, naquele período, 21.786 primeiras consultas na área da saúde mental, 85% das quais com prioridade “Normal”, 12% “Prioritárias” e 3% “Muito Prioritárias”.

Apurou-se que 39% dos utentes foram atendidos com tempo de espera superior aos tempos máximos de resposta garantidos (TMRG) fixados legalmente²², sendo esta realidade mais grave no caso dos utentes “Muito Prioritários” (mais de metade foram atendidos em incumprimento do TMRG previsto).

Note-se que a taxa de incumprimento dos TMRG considerando todos os níveis de prioridade é cerca de 11 pontos percentuais inferior nas consultas da área de saúde mental face à taxa registada na globalidade das consultas realizadas nos hospitais do SNS neste período (i.e., de todas as especialidades). Todavia, nos casos dos utentes “Prioritários” e “Muito Prioritários”, as taxas de incumprimento da saúde mental são, respetivamente, 10 e 14 pontos percentuais superiores às globais, o que revela que o problema do incumprimento dos TMRG é consideravelmente pior na área da saúde mental nestes níveis de prioridade.

Apurou-se também que, no final do período em apreço havia perto de 20.000 utentes em espera. Deste conjunto de utentes, 57% dos utentes “Muito Prioritários”, 45% dos “Prioritários” e 29% dos utentes com prioridade “Normal” já tinham ultrapassado o TMRG naquela data.

²² Tempos fixados na Portaria n.º 153/2017, de 4 de maio.

Tabela 4 – Tempos de espera para atendimento nas especialidades de psiquiatria, psiquiatria da infância e da adolescência e psicologia, no primeiro semestre de 2023

Indicador	Nível de prioridade			
	Muito Prioritário (TMRG 30 dias)	Prioritário (TMRG 60 dias)	Normal (TMRG 120 dias)	Todas as prioridades
Consultas realizadas durante o semestre				
Número de utentes	735	2.626	18.425	21.786
%>TMRG	54%	45%	37%	39%
Média do TE (dias)	57	74	112	105
Mediana do TE (dias)	34	55	98	90
Utentes em lista de espera para consulta no final do semestre				
Número de utentes	677	1.662	15.505	17.844 ²³
%>TMRG	57%	45%	29%	-

3.3. Oferta de cuidados de saúde mental nos hospitais

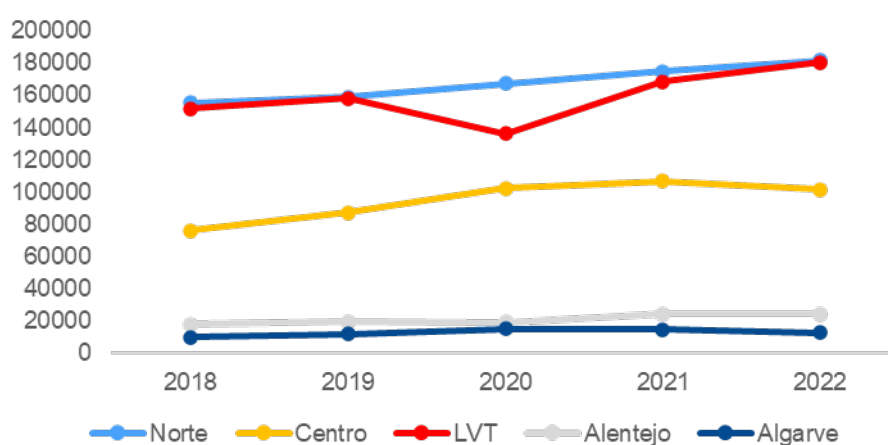
Na presente secção analisa-se o volume de atividade dos hospitais do SNS em diferentes serviços relacionados com a área da saúde mental, na perspetiva desse volume de atividade revelar o nível de acesso concretizado a estes cuidados de saúde pelas populações.²⁴

Em primeiro lugar, atente-se à atividade de prestação de consultas de psiquiatria (incluindo de adultos e de infância e adolescência). De acordo com os dados recolhidos pela ERS junto dos hospitais do SNS, o volume de consultas tem crescido de forma sustentada desde 2018, a uma taxa média anual de 5%, tendo-se registado uma inflexão em 2020 apenas nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo.

²³ Foram excluídos 2.010 utentes que nos dados recolhidos surgem com prioridade “não especificada”.

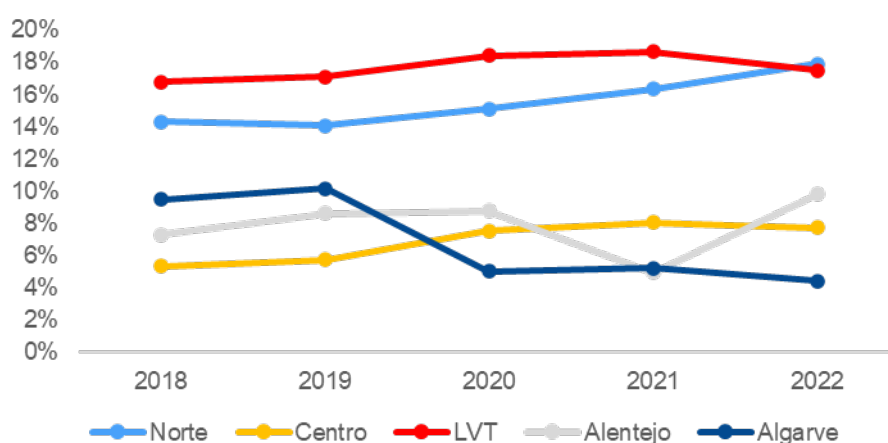
²⁴ Com efeito, a análise da produção de cuidados de saúde revela apenas a parte da procura de cuidados de saúde efetivamente satisfeita. A parte da procura não satisfeita – e a correspondente ponderação na análise do acesso – terá necessariamente de ser inferida a partir de outros indicadores como, por exemplo, o número de utentes em lista de espera para consulta.

Figura 6 – Número de consultas de psiquiatria realizadas nos hospitais do SNS



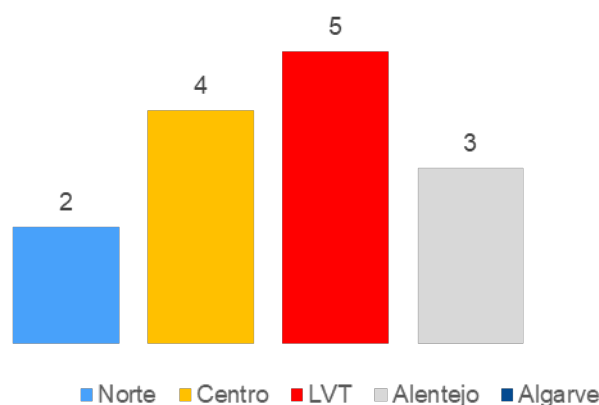
Ao longo de todo o período de 2018 a 2022, o peso das consultas da infância e adolescência no total de consultas de psiquiatria manteve-se globalmente constante, em cerca de 11%, sendo regionalmente assinalável a queda deste peso no Algarve a partir de 2020 (de 10% para 5%).

Figura 7 – Peso das consultas da infância e adolescência no total de consultas de psiquiatria



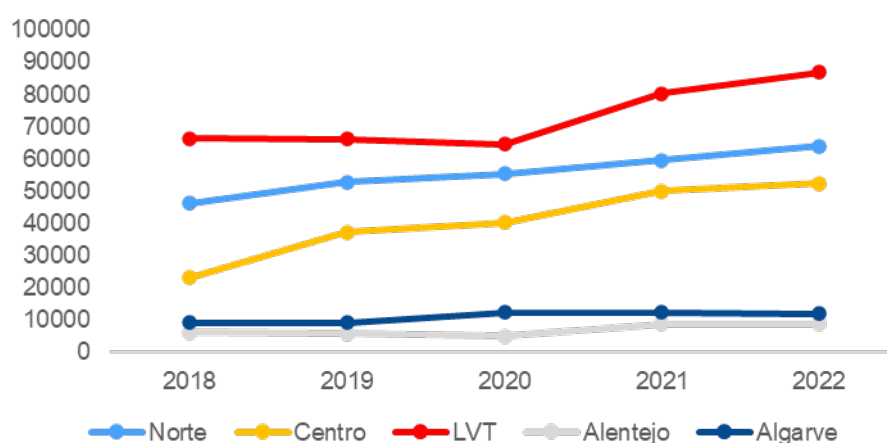
Colocando agora o foco nas consultas de psicologia, recupera-se aqui a informação já referida de que são apenas 14 os hospitais que recebem utentes referenciados da rede de cuidados de saúde primários do SNS para consulta desta especialidade.

Figura 8 – Número de hospitais da região que recebe referências dos cuidados de saúde primários para consultas de psicologia



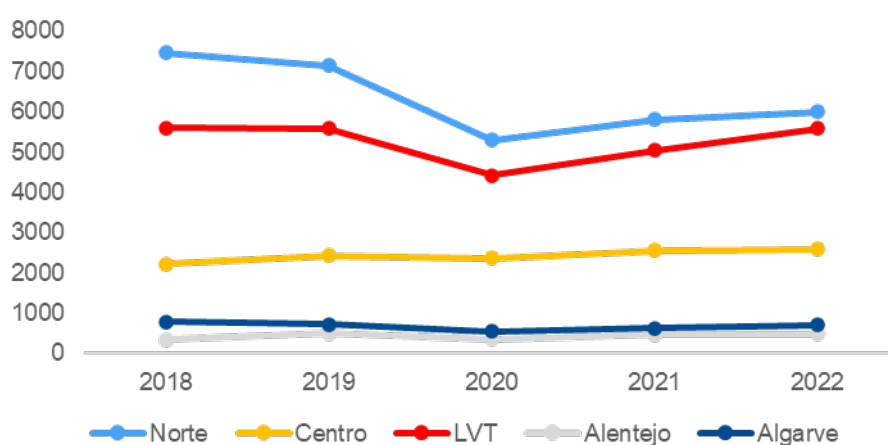
No período em análise, o número de consultas de psicologia realizadas nos hospitais do SNS cresceu todos os anos a nível nacional (ainda que menos em 2020), a uma taxa média de crescimento anual de 12%. A região Centro destaca-se por apresentar no período a maior taxa de crescimento, com o número de consultas a aumentar em média 32% por ano.

Figura 9 – Número de consultas de psicologia realizadas nos hospitais do SNS



Em sentido inverso às consultas, o número de internamentos em saúde mental apresentou uma redução média de cerca de 2% ao ano a nível nacional, devendo, todavia, assinalar-se variabilidade nesta atividade em dois eixos: a nível temporal, verificou-se uma redução acentuada no número de internamentos em 2020, seguida de um aumento nos anos seguintes; a nível regional, esta redução em 2020 fez-se sentir sobretudo no Norte e em Lisboa e Vale do Tejo.

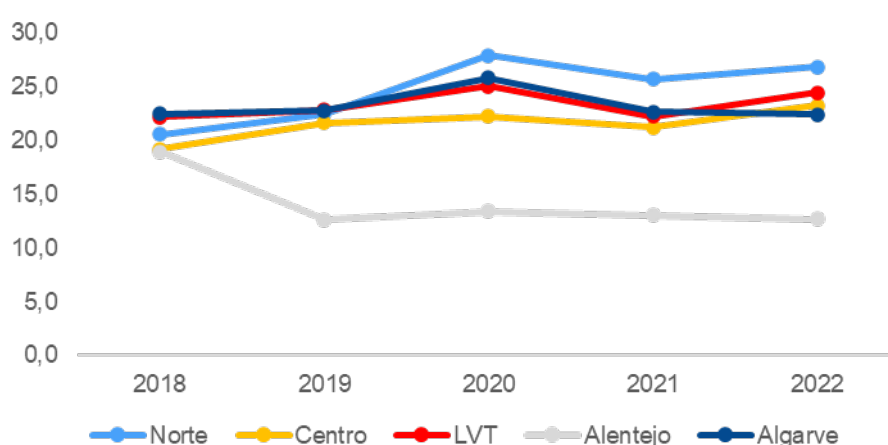
Figura 10 – Número de internamentos na área da saúde mental nos hospitais do SNS



A demora média dos episódios de internamento de saúde mental, medidos em dias, é significativamente superior à da média dos internamentos de todas as especialidades. Com efeito, em 2022 registou-se uma duração média de um internamento em saúde mental de 21,9 dias, o que se desvia 149% dos 8,8 dias de média quando se considera todos os internamentos no mesmo ano.

Apenas com a exceção do Alentejo, as regiões revelaram demoras médias numericamente próximas e com um perfil temporal igualmente pautado por um aumento da duração do internamento em 2020 que estabilizou nos anos seguintes.

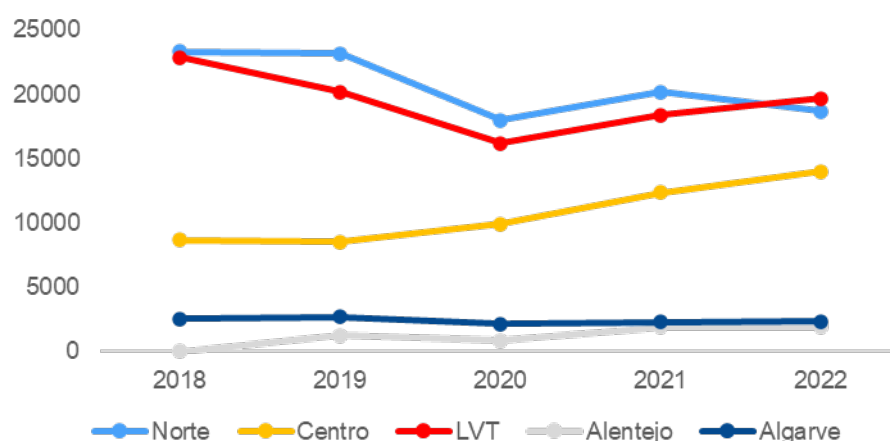
Figura 11 – Demora média do internamento de saúde mental (em dias)



Finalmente, constata-se que o número de episódios de urgência de saúde mental apresentou um crescimento médio anual no período próximo de zero, em todo o território continental, embora tal média contenha dinâmicas regionais distintas que importa realçar: Norte e Lisboa e Vale do Tejo

registaram uma redução no número de urgências no período (mais acentuada em 2020), o Centro apresentou crescimento em todos os anos e Alentejo e Algarve representaram uma parcela pequena do total de episódios de urgência (inferior a 8% no seu conjunto).

Figura 12 – Número de episódios de urgência de saúde mental nos hospitais do SNS



3.4. Oferta de cuidados de saúde mental na comunidade pelos hospitais

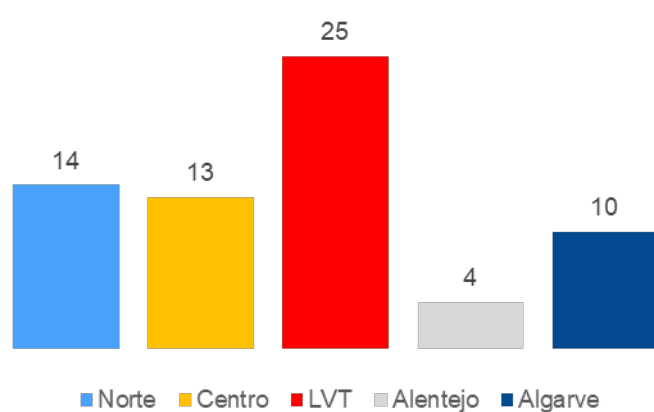
Nesta última secção sobre a análise do acesso, apresentam-se as constatações relativas à atividade de cuidados de saúde mental na comunidade asseguradas pelos hospitais do SNS.

Refira-se que o PNSM tem como valores a preferência pelos cuidados na comunidade. De acordo com este plano, “as equipas comunitárias de saúde mental para a população adulta (ECSM-PA) e as equipas comunitárias de saúde mental para a infância e adolescência (ECSM-IA), de composição multidisciplinar, têm como objetivo aproximar os serviços de saúde mental da população que acompanham e assegurar respostas focadas na prevenção, através do melhor entendimento do contexto onde as pessoas vivem e adoecem, permitindo uma intervenção mais efetiva nos problemas de saúde mental. As ECSM-PA e ECSM-IA seguem um modelo sistémico na abordagem das pessoas com doença mental, devendo assegurar que o tratamento decorre na comunidade, em articulação com outros profissionais de saúde e outros níveis de cuidados, contribuindo para a redução do estigma e da discriminação, frequentemente associados à doença mental”.²⁵

²⁵ Cfr. Despacho n.º 2753/2020, de 28 de fevereiro.

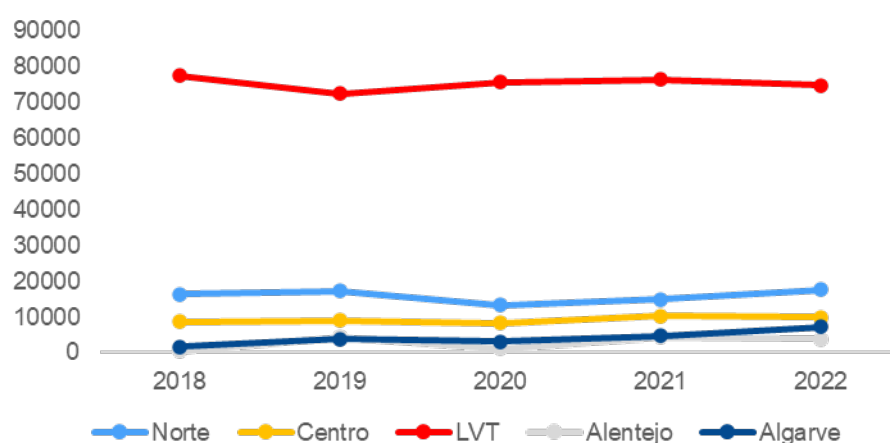
Com efeito, no levantamento de informação realizado pela ERS incluiu-se a contabilização do número de equipas comunitárias de saúde mental dos hospitais do SNS efetivamente constituídas e em operação. Neste sentido, apurou-se a existência de um total de 66 equipas, distribuídas regionalmente conforme se pode verificar na figura 13. Do total de 47 entidades hospitalares em apreço, 22 não dispõem de qualquer equipa comunitária de saúde mental e que as restantes 25 têm em média 2,6 equipas.

Figura 13 – Número de equipas comunitárias de saúde mental



Ora, o número significativamente superior de equipas existentes nos hospitais da região de Lisboa e Vale do Tejo é acompanhado de um peso muito significativo desta região no volume total de consultas de saúde mental na comunidade realizadas pelos hospitais do SNS (concretamente, em 2022, 66% destas consultas foram realizadas em Lisboa e Vale do Tejo).

Figura 14 – Total de consultas de saúde mental na comunidade realizadas pelos hospitais do SNS



3.5. Oferta de teleconsultas de psiquiatria pelos hospitais

Em junho de 2023 a ERS publicou um estudo que realizou com o objetivo de analisar o âmbito e a natureza dos serviços de telemedicina, bem como a oferta existente e o acesso a estes serviços nos hospitais do SNS.²⁶

De entre as várias conclusões extraídas do estudo, destaca-se a constatação da existência de uma grande heterogeneidade nos critérios de registo da atividade desenvolvida como teleconsultas ou como consultas médicas sem a presença do utente nos hospitais do SNS, o que, pelo menos em parte, poderia justificar as inconsistências verificadas entre a informação sobre o volume de atividade em teleconsultas constante do Portal da Transparência do SNS e a reportada pelos prestadores à ERS.

O levantamento de informação realizado junto dos hospitais no âmbito desse estudo continha, entre outros dados, informação sobre as especialidades nas quais cada hospital oferecia teleconsulta. Assim, apresenta-se na tabela 5 o que se apurou nesta matéria à data de janeiro de 2022.

Como se pode verificar, 16 entidades hospitalares do SNS ofereciam consultas de psiquiatria em modalidade de teleconsulta, mas apenas três o faziam para a área da psicologia.

Tabela 5 – Número de entidades hospitalares do SNS que oferecem teleconsultas de saúde mental²⁷

Região	Teleconsulta de psiquiatria	Teleconsulta de psicologia
Norte	6	1
Centro	3	0
LVT	5	2
Alentejo	2	0
Algarve	0	0
Total	16	3

²⁶ Disponível no *website* da ERS, em <https://www.ers.pt/pt/comunicacao/destaques/lista-de-destaques/prestacao-de-servicos-de-telemedicina-nos-hospitais-do-servico-nacional-de-saude/>.

²⁷ As análises realizadas têm como base as respostas dadas pelos prestadores a um pedido de elementos da ERS, remetido a 49 entidades no dia 11 de janeiro de 2022.

4. Conclusões

Seguindo uma tendência globalmente verificada na Europa, a incidência de problemas de saúde mental na população portuguesa tem aumentado ao longo dos anos, justificando um acompanhamento atento por parte da ERS à evolução desta área de cuidados de saúde.

Assim, este estudo teve como objetivo analisar diversas vertentes do acesso a cuidados hospitalares de saúde mental no SNS.

Neste âmbito, com base num levantamento de informação realizado junto de todos os hospitais do SNS, relativo ao período de 2018 a 2022, apurou-se, no essencial, que:

- 43 entidades hospitalares oferecem consultas de psiquiatria e 39 oferecem consultas de psicologia, sendo certo que 14 destas recebem utentes referenciados dos cuidados de saúde primários para consulta de psicologia; a oferta de serviços de internamento e de urgências na área da saúde mental acontece em, respetivamente, 33 e 22 entidades hospitalares;
- todas as entidades hospitalares abrangidas pelas Redes de Referência Hospitalar atualmente em vigor (a de Psiquiatria e Saúde Mental de Adultos, de 2014, e a de Psiquiatria da Infância e da Adolescência, de 2018) oferecem consultas de psiquiatria;
- estima-se que a RRH de adultos cubra 74% da população do território de Portugal continental até 30 minutos e que a cobertura aumente para os 95% quando se considera um tempo limite de 60 minutos; por seu turno, a RRH da infância e da adolescência cobrirá cerca de 71% da população a 30 minutos e 94% a 60 minutos;
- as dotações de recursos humanos afetos a cuidados de saúde mental nos hospitais do SNS, relativas à população residente nas regiões de saúde, cresceram de 2013 para 2022 nos três tipos de profissionais de saúde considerados (médicos psiquiatras, psicólogos e enfermeiros), tendo o crescimento mais acentuado sido verificado no rácio de psiquiatras por 75.000 habitantes da região;
- durante o primeiro semestre de 2023, 39% dos utentes foram atendidos em consulta hospitalar para lá dos TMRG fixados legalmente, taxa de incumprimento cerca de 11 pontos percentuais inferior à taxa registada na globalidade das consultas realizadas nos hospitais do SNS neste período (i.e., de todas as especialidades); nos casos particulares dos utentes “Prioritários” e “Muito Prioritários”, as taxas de incumprimento relativas à área da saúde mental foram superiores às globais (10 e 14 pontos percentuais, respetivamente), o que

revela que o problema de incumprimento dos TMRG é consideravelmente pior na área da saúde mental, nestes níveis de prioridade;

- o volume de consultas de psiquiatria tem crescido de forma sustentada desde 2018, a uma taxa média anual de 5%; o número de consultas de psicologia cresceu todos os anos a nível nacional, a uma taxa média de crescimento anual de 12%;
- em sentido inverso, o número de internamentos em saúde mental apresentou uma redução média de cerca de 2% ao ano entre 2018 e 2022; a duração média de um internamento em saúde mental é de 21,9 dias, mais do dobro dos 8,8 dias de média de todos os internamentos;
- o número de episódios de urgência de saúde mental manteve-se constante no período analisado, embora com variabilidade relevante entre regiões do país;
- apurou-se a existência de um total de 66 equipas comunitárias de saúde mental dos hospitais do SNS efetivamente constituídas e em operação; o número significativamente superior de equipas existentes nos hospitais da região de Lisboa e Vale do Tejo é acompanhado de um peso muito significativo desta região no volume total de consultas de saúde mental na comunidade realizadas pelos hospitais do SNS (concretamente, em 2022, 66% destas consultas foram realizadas em Lisboa e Vale do Tejo).



RUA S. JOÃO DE BRITO, 621 L32
4100-455 PORTO - PORTUGAL
T +351 222 092 350
GERAL@ERS.PT
WWW.ERS.PT